

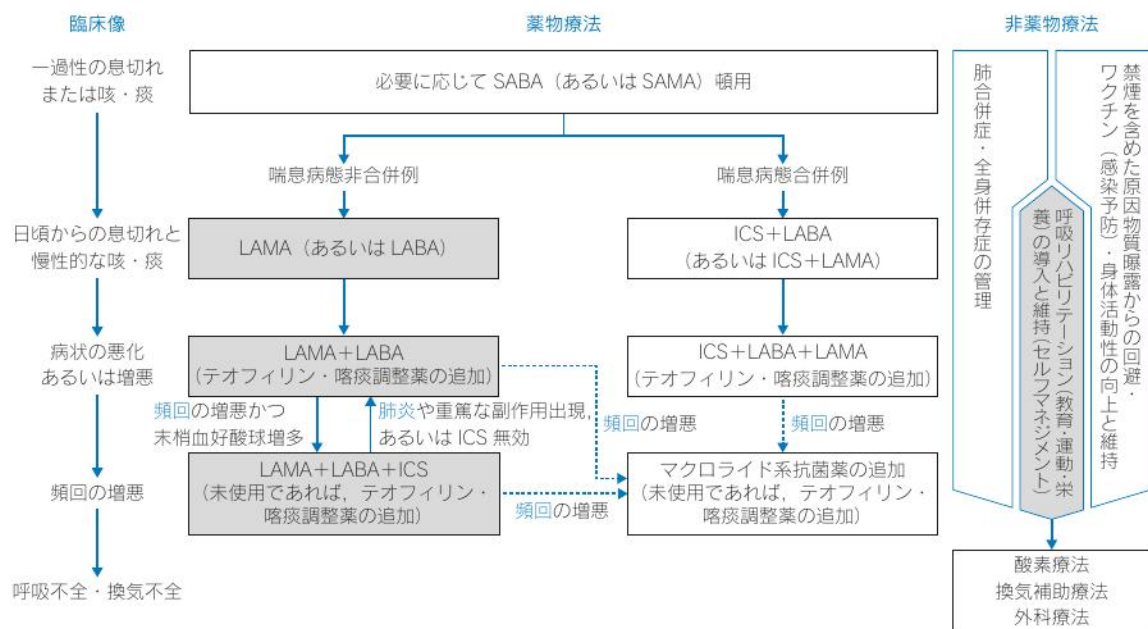


図1 安定期 COPD 管理のアルゴリズム

- ・COPD 患者は症状を過小評価しがちで、しばしば増悪を報告しないこともあるので詳細な聴取が重要である。質問票を用いて具体的に評価する。
- ・臨床像の評価は、初期治療導入時のみならず、病状の変化や治療の変更に合わせて、繰り返し重症度を評価することで、個別化最適医療の実現を目指すべきである。
- ・鑑別疾患を含めて肺合併症や全身併存症の予防・管理には、他科や他職種との連携は不可欠である。特に喘息（あるいは喘息病態）の合併は、薬物療法の選択のうえで重要である。
- ・喘息病態非合併患者で、ICS を追加した際の効果判定は重要である。安易な ICS の追加を避ける。無効あるいは副作用発症患者は中止を検討する。末梢血好酸球増多の目安として $300/\mu\text{L}$ 以上が用いられることが多い。喘息病態合併患者では、喘息病態が軽症の段階から LABDs に ICS を追加・継続する。LAMA が使用できない場合は LABA/ICS 配合薬を使用する。
- ・LAMA、LABA や ICS の長期管理薬使用中の増悪時には SABA（あるいは SAMA）を頓用する。また、長期管理薬を 2 割以上使用しても増悪が頻回であればマクロライド系抗菌薬を追加する。ただし、本邦でマクロライド系抗菌薬は COPD に保険適用はなく、クラリスロマイシンが好中球性炎症性気道疾患に保険収載されている。
- ・非薬物療法の禁煙、ワクチン、身体活動性の向上や維持は、疾患進行予防の観点からできかぎり早期からの導入を検討すべきである。軽症 COPD に対する早期呼吸リハビリテーション導入意義のエビデンスは乏しい。

[日本呼吸器学会 COPD ガイドライン第 6 版作成委員会（編）：COPD（慢性閉塞性肺疾患）診断と治療のためのガイドライン、第 6 版、メディカルレビュー社、p97、2022 より許諾を得て転載]

以上を対象とした新型コロナワクチン（対 SARS-CoV-2 ウイルス感染症）の定期接種や RS（Respiratory syncytial）ウイルスワクチン接種が推奨される。

呼吸リハビリテーション

呼吸リハビリテーションは、肺機能を改善させないが、呼吸困難の軽減、運動耐容能や QOL の改善に有効である⁵⁾。身体活動レベルを毎日維持させることが重要である。

栄養療法

痩せや体重減少は COPD 患者にとって生命予後不良の因子のひとつである。患者の多くはプレサルコペニアやサルコペニア状態であるとされている。COPD 患者は通常の呼吸であっても呼吸筋消費エネルギーが多く消耗性疾患であると認識されている。また全身性炎症に伴う摂取エネルギーの利用障害がある。ただし栄養補給療法は単独ではその効果が乏しく、運動療法と組み合わせることが重要である。運動療法と組み合わせると良いとされる栄養素材として、BCAA、ω3

系脂肪酸、ホエイ蛋白、多価不飽和脂肪酸や β -ヒドロキシ- β -メチル酪酸などが挙げられている。

酸素療法

在宅酸素療法（p235）および慢性呼吸不全（p491）の項目参照。システマティックレビューにおいて低酸素血症を伴う安定期 COPD 患者において酸素療法は弱く推奨されている¹⁾。高二酸化炭素血症を伴う呼吸不全 COPD 患者に対する在宅ネーザルハイフロー療法は従来の在宅酸素療法に比較して患者 QOL の改善および増悪を抑制できたことから 2022 年に保険収載された⁷⁾。

ii) 薬物療法

薬物療法は吸入療法を中心に、症状や QOL の改善、肺機能および運動耐容能や身体活動性、疾患進行や増悪の抑制、あるいは死亡率の抑制が期待できる。長時間作用性気管支拡張薬（LABDs）や吸入ステロイド薬（ICS）を用いる場合には喘息非合併か喘息合併 COPD の鑑別を要する。COPD における喘息合併